

LECCIÓN 10

COUNSELING

10.1 INTRODUCCIÓN

Finalizamos este curso con el capítulo counseling porque algunos clientes no están todavía abiertos para hacer una constelación o necesitan apoyo antes o después de una constelación.

PROPIO ESTILO

Una terapia que se orienta hacia el cliente no puede estipular lo que un terapeuta debe hacer sólo puede indicar pautas.

Cada terapeuta desarrolla su propio estilo. Es posible naturalmente tomando en consideración las tres condiciones bases de una buena actitud terapéutica: empatía, aceptación e integridad.

Todos los buenos terapeutas son a su manera simpáticos, uno es serio y lleno de atención, el otro lo hace con mucho humor y comprensión. La característica que comparten es escuchar con el corazón.

COMPROMISO

Es bueno comprender que un terapeuta que está muy profundamente comprometido con sus clientes cambiará también personalmente. Si una persona no está dispuesta a esto, quizás no sea la profesión adecuada. Se pide mucho de un terapeuta y a veces no es posible distanciarse lo suficiente para no ser afectado ya sea consciente o inconscientemente.

Es necesario no confundir nuestro propio sistema con el del cliente. Por ello es aconsejable haber completado el proceso de cambio de una conciencia basada en el ego a una conciencia basada en el corazón o por lo menos haber hecho notables avances antes de empezar a ayudar a otros.

DISCRECIÓN

Además es importante que el terapeuta pueda trabajar bien a solas. También es necesario mantener el secreto profesional. No es el tipo de profesión del que se puede hablar con la pareja o los amigos. Ya que a menudo se trata de casos difíciles y duros, es una buena costumbre no apegarse. No es conveniente para la salud mental del terapeuta, a largo plazo, llevarse esta carga emocional a casa. Es un requisito mantener relaciones propias gratificantes para no buscarlas en las relaciones terapéuticas.

Una separación de la vida laboral y privada es también recomendable para evitar problemas. Soltar la idea de controlar el resultado terapéutico es también una buena práctica ya que muy a menudo hay sorpresas; por ejemplo alguien hace una notable mejoría en corto tiempo y alguno de quien se esperaba rapidez resulta ir en retroceso.

La vida no se puede controlar. Ten confianza en que el amor se revela de diversas maneras.

LA MOTIVACIÓN INTERNA

Un terapeuta que empieza su labor no debe dejarse guiar por la ganancia material: de la terapia no te haces rico, a menos en sentido material. Solamente es recomendable la profesión de terapeuta cuando tienes un genuino interés en los procesos psíquicos y emocionales. Una buena fantasía y facilidad de expresión son cualidades apropiadas para poder empatizar con tus clientes. No tenerle miedo a las facetas oscuras de la vida porque forman parte de ella. Las cualidades internas son generalmente de mayor valor que los diplomas aunque estos son útiles ya que les dan confianza a tus clientes en tus capacidades.

CONOCERSE BIEN A SÍ MISMO

El conocerse bien a sí mismo es muy importante para el terapeuta: debes saber lo que puedes y también lo que no puedes. Es muy valioso poder referir un cliente a otros terapeutas cuando por cualquier razón no es posible ayudarlo. Por ejemplo, un cliente necesita ayuda porque ha finalizado una relación de muchos años y el terapeuta se encuentra precisamente en esas circunstancias. Durante su trabajo puede naturalmente distanciarse de sus problemas personales pero también sabe que se le hará muy difícil cuando los problemas de su cliente le recuerden sus propios problemas de relación.

LA INTERACCIÓN CON EL CLIENTE

La terapia es siempre interacción. A veces simpatizamos inmediatamente y a veces se nos hace totalmente imposible. Es difícil determinarlo de antemano ya que se trata de seres humanos. Puede ser que tengamos los mismos intereses que un cliente o que hayamos crecido en el mismo entorno o no tener nada en común. Si el cliente nos agrada mucho, es naturalmente algo muy bueno pero no debemos dejarnos llevar por la familiaridad. Siempre mantendremos en mente que se trata de una terapia en la que trabajamos con un problema del cliente. Además de los factores que no podemos controlar, el efecto de la terapia depende de las cualidades del terapeuta y de la motivación del cliente. La paciencia es una cualidad muy importante porque la terapia puede ser dificultosa y larga.

ESTAR EN EL MOMENTO PRESENTE

Los terapeutas con experiencia pueden mantenerse cómodamente en el momento presente. En lugar de aferrarse al pasado y preocuparse por el futuro, son más conscientes del momento presente. Sólo en el presente es posible hacer cambios: hemos dejado ya atrás al pasado y el futuro todavía no ha llegado. Además los terapeutas con experiencia son a menudo más suaves porque saben por su propia experiencia y el contacto con los clientes que la vida puede parecer difícil para un cliente aunque se trate de un problema cuya solución es aparentemente fácil.

LA ADMINISTRACIÓN DE UN TERAPEUTA

No es lo primero en que pensamos cuando hablamos de una terapia pero un terapeuta también necesita una buena administración. Generalmente tienes varios clientes en un día o semana y es necesario tener todos los datos en orden. Pon por escrito tus observaciones, las citas concertadas y si el cliente ha hecho el pago. Muchos terapeutas tienen una página Web lo que le permite a los clientes potenciales formarse una primera impresión.

LOS DATOS DE UN CLIENTE

Es necesario obtener en primer lugar la mayor información posible del cliente. Esta información se recopila durante la primera cita. Todos los datos se registran en el dossier del cliente. Es posible que durante el transcurso de la terapia sucedan tantas cosas que sea necesario revisarlos en el curso de la terapia.

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN UNA RELACIÓN TERAPÉUTICA

Cuando un terapeuta acepta un nuevo cliente, acepta también la obligación de ayudarlo de la mejor manera posible. La compensación del cliente consiste en el pago de acuerdo con la tarifa estipulada. Es importante que ambos sean conscientes de las obligaciones mutuas para que la terapia no se convierta en algo informal.

El cliente tiene naturalmente el derecho de interrumpir la terapia en cualquier momento. El terapeuta debe aceptarlo aunque no considere que sea una buena decisión. El cliente tiene la libertad de decidir por sí mismo si continua con la terapia o si cambia de terapeuta. Si el cliente decide interrumpir la terapia es una buena idea preguntarle el porqué. Esta información le permite aprender de su funcionamiento como terapeuta y que impresión tienen los clientes. Por otra parte, el terapeuta tiene también el derecho de finalizar la terapia pero únicamente con buenas razones.

10.2 PREPARACIÓN PARA UNA CITA

EL ENFOQUE DE LA TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE

El enfoque actual de la terapia está basado en el modelo del psicólogo americano Carl Ransom Rogers. Según su visión los clientes tienen mucho conocimiento y experiencia referente a sus problemas.

Los terapeutas tienen la capacidad de analizar estos problemas y guiarles. De esta manera la terapia se convierte en un intercambio entre el terapeuta y el cliente. Finalmente se trata de ayudar al cliente a encontrar sus propias respuestas. La cooperación entre el terapeuta y el cliente es central en este enfoque.

EL MODELO TERAPÉUTICO

- El terapeuta y el cliente trabajan juntos con el problema.
- El terapeuta le ofrece al cliente un espacio al escucharle con atención.
- El terapeuta profundiza en el problema.
- El terapeuta estimula al cliente a encontrar una solución al problema.

Muchos terapeutas trabajan según este modelo ya que se ha comprobado su valor. El terapeuta investiga el problema y no hace conclusiones rápidas. La esencia del problema está clara y se puede trabajar a continuación con él. No es usual que en una primera cita llegue a la profundidad de un problema, generalmente se necesitan varias sesiones.

En este modelo no se trata de darle o negarle al cliente la razón. Si un cliente experimenta algo como un problema, entonces es un problema.

LAS FASES DEL MODELO TERAPÉUTICO

- Aclarar: obtener claridad respecto a la ayuda que requiere el cliente.
- Matizar: el cliente intuye nuevas comprensiones, el punto de cambio en la terapia.
- Trabajar: Poner en práctica el nuevo comportamiento para alcanzar el objetivo.

ACLARAR

Es necesario tener una idea clara del problema del cliente al iniciar el contacto. La pregunta debe ser concreta. En primer lugar, el terapeuta escuchará el relato del cliente y si fuese confuso o incompleto le hará preguntas. A menudo se trata de temas personales dolorosos por lo que generalmente se relatan con dudas y mucho cuidado. Ya que a veces el cliente no tiene una idea clara de su problema se le dificulta comunicarlo de una manera transparente. Por ello es muy importante permitir que el cliente hable lo más posible y escuchar cuidadosamente lo que él dice. A fin de cuentas el cliente sabe mejor que nadie lo que siente y ha vivido. Él debe notar que puede confiar en el terapeuta por lo que podrá comunicarse más libremente. El terapeuta debe después de un tiempo poder destilar el problema. Puede resultar ser algo totalmente distinto de lo que en un principio presentó como el problema a solucionar.

MATIZAR

La siguiente fase en este modelo es matizar que también podemos definir como “una diferenciación muy sutil”. La imagen ya matizada es una imagen muy diferenciada del problema. El terapeuta toma una actitud más activa en esta fase y estimula al cliente a investigar otras posibilidades. Se trata de permitirle al cliente intuir nuevas comprensiones que cambien su visión del problema. A veces puede haber un cambio total y generalmente se trata de pequeños cambios. El momento en el que se experimentan las nuevas comprensiones se denomina el punto de cambio en la terapia. Puede ser que el cliente tenga dificultad en aceptar las nuevas ideas o que se sienta inseguro y confuso. Esta fase se debe trabajar con ejemplos concretos de la vida del cliente para obtener una imagen más diferenciada. Un fallo que a menudo se hace en esta fase es que el terapeuta se apresura a encontrar soluciones para el problema del cliente, mientras que la solución debe surgir como consecuencia de las nuevas ideas del cliente. El cliente debe asumir su responsabilidad y no mantenerse dependiente del terapeuta. Este es el punto de partida de la terapia centrada en el cliente.

TRABAJAR

La tercera fase de este modelo terapéutico se trata de entrar en acción. En esta fase ya existe una relación de confianza entre el cliente y el terapeuta. El problema o los problemas están claros tanto para el terapeuta como para el cliente. El terapeuta debe apoyar al cliente cuando pone en práctica el cambio deseado. Es necesario establecer una meta real y tener su cooperación. La siguiente etapa en la fase de trabajo es hacer una evaluación junto con el cliente y decidir si integrará la meta directamente en la práctica o quiere practicar primero. Un buen ejercicio es el juego de papeles. Otra posibilidad es dividir la meta en pequeños pasos. En esta fase es importante hacer estos pasos concretos porque de otra manera es fácil posponer. No se debe presionar al cliente, él debe decidir lo que es realizable. Debe tener la libertad de no hacer el trabajo aunque el terapeuta no este de acuerdo.

10.3 DESTRAZA PARA CONDUCIR UN DIÁLOGO

Para poder funcionar bien como terapeuta es necesario tener una cierta destreza para conducir un diálogo. La terapia centrada en el cliente de Rogers indica únicamente ciertas cualidades en general como la empatía, aceptación y honestidad. Él deja la interpretación de estas cualidades a los terapeutas mismos. Lo que sí describió es la manera en la que un terapeuta se puede comunicar “emocionalmente” con su cliente y cuales son las ventajas y desventajas. Para entrenar a un terapeuta esta descripción resulta insuficiente por lo que se ha investigado como se caracterizan los terapeutas buenos y con experiencia. Las cualidades que estos terapeutas tienen se pueden aprender aunque siempre habrá diferencias en las aptitudes de los terapeutas principiantes.

Algunos tienen mayor facilidad en aplicar la teoría a la práctica cuando reconocen las diversas situaciones durante una terapia. Una combinación de talento y práctica continua sería lo mejor. Para conducir un diálogo terapéutico es necesario tener capacidades oratorias específicas. Es una habilidad también saberlas utilizar en el momento apropiado. Los terapeutas con experiencia muestran un comportamiento más efectivo que los principiantes. ¡La práctica hace al maestro!

COMUNICACIÓN EMOCIONAL EN LA TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE

Rogers no utilizó técnicas específicas en su terapia. El cliente determina el contenido y dirección de la terapia porque él sabe lo que le conviene. El terapeuta puede reaccionar de diversas maneras en una comunicación emocional con el cliente. El cliente muestra sus sentimientos y el terapeuta puede interactuar con él utilizando herramientas verbales y no-verbales. La reacción verbal se apoya con la parte no-verbal. Un cliente que rompe a llorar recibe palabras de consuelo y una mano en los hombros. Rogers divide las posibles reacciones de los terapeutas en cinco categorías. Cada una de las reacciones tiene un efecto diferente en el diálogo a continuación.

LA PRIMERA CITA

La primera cita se denomina el diálogo inicial. El terapeuta toma la iniciativa y empieza la conversación. Es recomendable empezar con una frase simple para romper el hielo como por ejemplo, “Pasa”, “Siéntate” o algo similar. Estas frases ayudan al cliente a relajarse y sentirse a gusto. A continuación se realiza la anamnesis: los datos más importantes y los hechos relevantes de la historia del cliente se anotan. Es conveniente anotar toda la información relevante posible ya que el terapeuta puede en ella encontrar puntos de partida. Naturalmente también es posible que inmediatamente surja una contra-indicación por lo que el terapeuta tendría que referir al cliente a otro terapeuta. Personas con psicosis o en situaciones agudas de crisis pueden obtener un tratamiento adecuado rápidamente. Esta manera de trabajo parece un poco fría pero es de importancia porque se obtiene claridad a corto plazo. Es recomendable informar al cliente de lo que puede esperar de la terapia y la manera de trabajar. El cliente puede entonces decidir si responde a sus expectativas. Puede ser que el cliente espere recibir algo que el terapeuta no puede ofrecer. Entonces es necesario decirlo de una manera clara. Es aconsejable tener presente el mundo del cliente. Una persona con una educación sencilla necesita un lenguaje sencillo. Lo que el cliente quiere es empezar la terapia. El mensaje debe ser bien recibido por el cliente. Si ambos están de acuerdo se puede hacer lo que se conoce como el contrato inicial. Este es un acuerdo verbal en el que se indican las pautas a seguir durante la terapia.

Cuando la terapia empieza, el terapeuta y el cliente pueden clarificar el problema. ¿Por qué necesita el cliente terapia, qué quejas tiene y qué expectativas? Lo más importante es establecer una relación de confianza en la que el cliente se sienta cómodo y se pueda expresar libremente. La primera cita es siempre difícil y puede intimidar al cliente. Este se muestra vulnerable al relatar sus problemas personales a una persona todavía desconocida. Además el cliente puede tener la idea que ha fracasado al requerir ayuda para solucionar sus problemas. El pedir ayuda es naturalmente humano pero el cliente lo puede ver de otra manera. Este tipo de sensibilidad debe tomarse en cuenta. Generalmente el cliente no expresa todo lo que el terapeuta necesita saber. Si este invierte primero en establecer una buena relación, la recompensa será grande más tarde en la terapia.

LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR DE UNA MANERA NO SELECTIVA

La más importante habilidad de una terapeuta es escuchar con atención para que el cliente pueda expresarse. El terapeuta no se mantiene en silencio sino que escucha activamente. El cliente se siente estimulado por un terapeuta que le presta atención y quizás aún más cuando le escucha intrigado. Esto parece automático y fácil de llevar a cabo pero no es así. Especialmente los terapeutas principiantes quieren ayudar tanto que inmediatamente empiezan a decir o hacer algo. Por ello no pueden tener la calma de escuchar lo que el cliente dice. De esta manera el cliente no tiene el espacio para comunicar su problema. Está claro que el terapeuta tiene muchas cosas en su mente cuando habla con un cliente. Durante el diálogo surgen las ideas referentes a los posibles orígenes del problema. El terapeuta ordena estos pensamientos interpretándolos. Interpretar significa en este caso aclarar o clarificar.

El interpretar en el sentido terapéutico difiere de la interpretación común ya que el terapeuta lo hace basado en un fondo teórico. También hay una diferencia en la manera en que las interpretaciones se ajustan a lo que el cliente relata. Por un lado, el terapeuta puede dar una interpretación de algo que ya era conocido por el cliente. Por otro lado, algunas de las interpretaciones tratan temas desconocidos para el cliente y pueden ser el origen de nuevas comprensiones.

EL MOMENTO JUSTO DE INTERPRETACIÓN

Las interpretaciones no son indicadas en la fase de aclaración del problema. Es muy posible que surjan en la mente del terapeuta y que decida no esperar hasta la fase de matización. Así también puede esperar y no compartir sus interpretaciones con el cliente. Hay diversas razones para ello.

COMPARTIR INFORMACIÓN

Puede ser útil expresar en lenguaje común, sin extenderse y explicar teorías, el conocimiento teórico del terapeuta al cliente. De esta manera puede explicar el porqué de ciertos procedimientos cuando el cliente no los comprende. La información teórica puede aumentar la comprensión del cliente.

LAS TÉCNICAS PARA MATIZAR

Las diversas capacidades de matización concretas que el terapeuta puede utilizar se especifican a continuación:

EMPATÍA

Con esta capacidad el terapeuta demuestra comprensión al reflejarse en los sentimientos del cliente y una comprensión profunda de lo que sucede en su interior. El terapeuta demuestra su empatía pero de una manera sutil. A menudo se trata de aspectos que son difíciles de aceptar: características de la personalidad que son menos apreciadas o su propio papel en situaciones dolorosas.

El terapeuta escucha con “antenas” y trata de juntar las piezas de un rompecabezas: lo que el cliente expresa, su actitud y la manera de expresarse. Todos estos elementos combinados proporcionan buenas pistas para completar el rompecabezas.

RE-ETIQUETAR POSITIVAMENTE

Una manera de estimular al cliente a llegar a una comprensión positiva es la técnica que se conoce como re-etiquetar positivamente. Esta capacidad proporciona un nuevo significado a un aspecto del problema que ha sido considerado como negativo.

Las quejas o síntomas no se esconden, solamente se acentúa el lado positivo de las mismas. No cambia nada de la situación aunque se le dé una connotación positiva.

PROPORCIONAR FEED-BACK INMEDIATO

Esta capacidad se utiliza cuando el terapeuta nombra el comportamiento del cliente en el momento en que tiene lugar (el presente) y lo cuestiona. Feed-back significa literalmente reconectar con lo comunicado. Al proporcionar feed-back inmediato el terapeuta interrumpe el diálogo para indicarle al cliente algo en la manera de comunicarse o actuar que ilustra su problema.

SOLUCIONAR LOS DILEMAS

El cliente expone a menudo sus dilemas. Estos son problemas con más de una solución. Cada una de las soluciones tiene desventajas. Un dilema consiste literalmente en escoger entre dos alternativas. El cliente no encuentra la solución porque le da vueltas al problema continuamente en su cabeza.

El terapeuta puede asistir al cliente investigando las posibles soluciones. Lo puede hacer a través de las diversas técnicas para llegar a una imagen concreta y pueden surgir otras soluciones totalmente diferentes.

EL PLAN DE ACCIÓN

Se puede formular un plan de acción cuando es evidente que el cliente quiere cambiar y tiene una meta realista. El cliente y el terapeuta pueden recorrer los siguientes pasos:

- Considerar el resultado de los propios intentos del cliente.
- Formular sub-metas concretas.
- Evaluar y ajustar las acciones.
- Concluir la terapia.

LOS PROPIOS INTENTOS DEL CLIENTE

A menudo el cliente ha tratado de solucionar su problema de muchas maneras antes de buscar ayuda de un terapeuta. Posiblemente lo ha hecho en otra fase del problema. Es recomendable evaluar lo que el cliente ha intentado por su propia cuenta para encontrar una solución una vez que se ha formulado una meta realista. ¿Qué tuvo resultado, que no y porqué?

También es útil ver en qué forma el entorno del cliente puede cooperar. ¿Quiénes son las personas importantes en la vida del cliente y de qué forma pueden ayudarle a alcanzar la meta? Esta información se puede integrar en el plan de acción.

FORMULAR SUB-METAS CONCRETAS

La meta del cliente se debe dividir en sub-metas. El alcanzar las sub-metas estimula al cliente y el camino hacia la meta final se hace más claro. Una sub-meta debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Formulada de una manera específica y concreta y con indicaciones del tiempo requerido. Por ejemplo: Para completar una carrera en cuatro años (meta realista) es necesario que un estudiante apruebe el primer examen (la primera sub-meta) y continuación apruebe el primer año (una sub-meta más lejana).
- Cercana en el tiempo porque estimula a tomar acción. Por ejemplo: El obtener un diploma después de cuatro años no estimula a un estudiante a entrar en acción pero aprobar un examen que se presenta dentro de cuatro semanas sí.
- Un grado de dificultad estimulante: si las sub-metas son demasiado fáciles, no forman un reto y si son difíciles pueden asustar. Por ejemplo: Si los exámenes son demasiado fáciles no estimulan a los estudiantes a esforzarse y si son demasiado difíciles pueden asustarles. En ambos casos la probabilidad de aprobar el examen es muy pequeña.
- Al aspirar a alcanzar las sub-metas, el cliente no debe de perder de vista la meta final ya que ésta es la motivación final. El terapeuta puede mencionar la meta principal cuando el cliente se siente desmotivado. Además es importante que se describa y prepare la primera sub-meta adecuadamente ya que el alcanzarla le proporcionará una buena motivación. La presión no debe ser grande y un fracaso no significará que debe perder la esperanza.

EVALUAR Y CORREGIR LAS ACCIONES

El siguiente paso en la fase de tomar acción es evaluar las experiencias vividas y los esfuerzos para alcanzar las sub-metas.

El terapeuta debe contemplar la posibilidad de que la meta no sea alcanzada o se alcance sólo en parte.

El cliente se encuentra en un proceso de aprendizaje. Por ello es para el terapeuta normal no perder la paciencia y mantener un clima agradable. Si el terapeuta lo confronta con su fracaso podría perder rápidamente su motivación. El terapeuta debe tener en mente los siguientes puntos:

- Mostrar comprensión por los sentimientos del cliente y aceptar posibles fracasos.
- Mencionar también los pequeños éxitos. Muy a menudo el cliente los olvida y es muy valioso recordárselos.
- Aprender de los fallos: ¿Qué fue mal y cómo lo podemos mejorar? Los clientes se olvidan también a menudo de este punto.
- Prestar atención a las ideas y sentimientos del cliente al mismo tiempo que se consideran los hechos. El nuevo comportamiento crea nuevas experiencias para el cliente. Es importante que el cliente asimile estas experiencias de una manera correcta y que no se detenga demasiado tiempo en ellas.

CONCLUIR LA TERAPIA

En la práctica, una terapia dura entre un par de meses y un año. En el mejor caso la meta que el cliente se ha formulado ha sido alcanzada al concluir la terapia pero no es absolutamente necesario. El terapeuta debe evaluar por sí mismo si tiene sentido continuar.

10.4 LAS EMOCIONES Y LA TERAPIA

LAS EMOCIONES MÁS COMUNES EN LA TERAPIA

¿Cómo identifica un terapeuta las emociones y de qué manera las debe tratar? A continuación tratamos las tres emociones más comunes: el miedo, la rabia y la tristeza.

La emoción básica, la felicidad, no se menciona ya que no es una emoción por la que se solicita ayuda de un terapeuta. Se le debe prestar atención a los sentimientos de amor romántico establecidos, en ocasiones, por parte del cliente hacia el terapeuta.

EL MIEDO

Esta es una de las emociones más comunes en la terapia. Por ello se conocen tantas enfermedades relacionadas con el miedo. El miedo es una señal muy útil para las personas: les alerta, agudiza los sentidos y eleva el nivel de reacción. Esto sucede al activarse el sistema nervioso simpático de tal manera que el cuerpo se encuentra en estado de alerta. Así se puede gritar, correr o luchar.

En la vida moderna hay pocos peligros concretos en los que podemos reaccionar de una manera inmediata. En su lugar existe el estrés continuo de la sociedad moderna: el tráfico intenso, el trabajo pesado, los límites de tiempo, las relaciones complejas, etc. Todas estas experiencias pueden ocasionar en ciertas personas leves sentimientos de miedo con los que no saben qué hacer. El cuerpo se encuentra en un estado continuo de ligera alerta mientras que no hay algo contra lo que se pueda reaccionar. Ya que el miedo no se puede descargar inmediatamente, va dejando sus huellas en el cuerpo: ojos dilatados, respiración cortada, músculos endurecidos en el cuello, hombros y espalda, mandíbulas tensas, etc. Las personas tienen a menudo miedo de todo: de sentir, de cambiar, de perder a una persona amada, de perder el trabajo, etc.

En la terapia nos encontramos con diversos estados de miedo, desde estados ligeros hasta verdaderas enfermedades, como las fobias e hiperventilación. El terapeuta puede evaluar la seriedad de la emoción y si el cliente debe ser dirigido a un psicólogo o psiquiatra. A veces es mejor tratar los casos graves de miedo en combinación con otras alternativas médicas.

El papel del terapeuta es desvelar el mensaje que encubre el miedo ya que esta emoción siempre tiene una función. Este mensaje puede surgir durante la terapia y el terapeuta puede utilizar diversas técnicas. Una vez que el cliente tiene suficiente comprensión de su miedo, podrá llevarlo de una manera mejor.

LA RABIA

Esta emoción es una reacción sana como respuesta al traspaso de un límite personal. El enfado nos sirve para protegernos. Si se expresa de una forma adecuada, le ofrece a las otras personas involucradas claridad. Los clientes cargan a menudo con mucha rabia reprimida porque no es aceptable en muchos lugares. Muchos clientes han aprendido a reprimir su enojo o furia de tal manera que ya no la pueden sentir. La rabia reprimida se puede reconocer por las mandíbulas comprimidas, los puños cerrados, la espalda rígida, voz alta, mirada penetrante, etc. Si esa situación se vive por mucho tiempo, puede derivar en una úlcera estomacal por la excesiva producción de ácido gástrico. La rabia reprimida que no se expresa se transforma en comportamiento autodestructivo: comer demasiado, fumar demasiado, beber demasiado. También el comportamiento destructivo hacia personas u objetos es posible: Criminalidad, vandalismo, terrorismo. De esta manera se calman las señales del cuerpo. Ya que el cliente no ha aprendido a manejar esta emoción, proporciona muchos problemas tanto para el cliente como para el terapeuta. Los clientes no saben expresar su rabia y los terapeutas no saben como contenerla o darle forma.

Es esencial que el cliente en terapia tenga la oportunidad de expresar su rabia de una manera aceptable. La tarea del terapeuta es velar para que suceda dentro de ciertos límites. Es muy importante que se exprese y sin ocasionar daños tanto físicos como verbales. El expresar la rabia le permite al cliente conectar nuevamente con su propia fuerza que solamente él puede manejar.

En general se necesita mucho tiempo para que los clientes puedan entrar en contacto con su propia rabia. Buscan ayuda por estados depresivos, por falta de energía, irritabilidad y adicciones. Al escuchar y observar detalladamente, el terapeuta puede discernir si se trata de rabia reprimida.

Esto puede verse en la conversación y a través de pequeñas señales que muestran algo diferente a lo que se expresa. La rabia está generalmente dirigida a situaciones o personas del entorno anterior o actual, los padres y ex-parejas. Se trata a menudo de abuso, incomprensión, abandono o negación. A veces también es dirigida al terapeuta. Esto sucede porque el cliente tiene la idea de que el terapeuta no le comprende, lo juzga o critica. Lo mejor es aceptar el enfado y ponerse en contacto con los sentimientos del cliente. Durante las consultas se puede profundizar en el origen de la rabia con las técnicas antes mencionadas.

A veces se trata de sentimientos transferidos: sentimientos que pertenecen a personas importantes en la vida del cliente que se transfieren hacia el terapeuta. La palabra transferencia tiene su origen en el psicoanálisis. Un cliente del sexo masculino tiene sentimientos de rabia hacia su padre que le abandonó y los proyecta hacia el terapeuta porque él lo vive como una figura paternal.

Si el terapeuta acepta esta transferencia se puede decir que hay una "Re-transferencia". En ese caso, el terapeuta confirma su papel de padre y trata al cliente como si fuese su hijo. Es importante evitar esta situación porque el terapeuta pierde totalmente su objetividad.

TRISTEZA

Esta emoción es una reacción natural cuando nuestros deseos y expectativas no se realizan, cuando debemos soltar algo con lo que estamos encariñados o cuando debemos despedirnos de alguien al que amamos. Todos tenemos adversidades en la vida y vivimos situaciones dolorosas. En realidad hay muchas cosas que no podemos controlar aunque lo tratemos con toda nuestra energía. A veces se expresa con sollozos (sacudiendo el cuerpo), las comisuras de los labios hacia abajo, las manos sobre la cara y el cuerpo hacia delante. En nuestra cultura este tipo de comportamiento se denomina infantil o femenino. Se considera una señal de debilidad especialmente cuando los hombres lloran. De esta manera se aprende a reprimir la tristeza a una temprana edad y a tratar de evadir el dolor. El resultado es falta de vitalidad. Los síntomas corporales de tristeza reprimida son: ojos apagados, la cabeza colgando, hombros caídos, un paso lento y arrastrado, el habla lenta y cansancio. Si la tristeza se reprime por mucho tiempo da lugar a depresión.

Cuando la tristeza se expresa, desaparecen estos síntomas. Muchos clientes tienen miedo a liberar estos sentimientos porque temen ser invadidos por la tristeza. Por ello es importante que el terapeuta cree una situación de seguridad en la que el cliente se permita mostrar su vulnerabilidad.

LA AUSENCIA DE EMOCIONES

Podríamos concluir después de describir las emociones que generalmente surgen en la terapia, que las sesiones terapéuticas siempre van acompañadas de gran emocionalidad. En realidad esto no es así, porque la emocionalidad en muchas sesiones está ausente. El terapeuta tiene mucha dificultad para que el cliente entre en contacto con sus emociones. Si algunos clientes se desbordan de emociones, otros no sienten nada o casi nada. Esto no es bueno porque el ser consciente de nuestras emociones es de vital importancia para la salud emocional y física. La ausencia de emociones puede notarse de diversas maneras y por ello es difícil para un terapeuta evaluarla.

- Algunos clientes hablan mucho pero siempre de temas superficiales. Están siempre haciendo cosas externas en lugar de hablar de sí mismos o de sus problemas. También pueden buscar continuamente racionamientos lógicos con los que no se pueden involucrar emocionalmente.
- Otros clientes no saben que decir, hay muchos silencios durante la visita. Durante los períodos de silencio se puede sentir la tensión entre el cliente y el terapeuta. El cliente no quiere o no puede hablar de sus emociones. Estos clientes sufren a menudo de depresión.
- Otros clientes fijan su atención en los problemas físicos para no ocuparse de sus emociones. Esto les parece más seguro que las emociones incontrolables.

Estos malestares se denominan psicosomáticos: problemas físicos con un origen emocional. El terapeuta debería tratar de crear una relación activa con el cliente y en esa relación dar un lugar a los sentimientos.

Una terapia no es sólo el intercambio de palabras sino que tiene como objetivo poner en movimiento algo en el mundo emocional del cliente.

AMOR

Esto no es realmente una emoción pero si un tipo de conexión que todas las personas pueden experimentar. Se considera una de las más importantes experiencias que podemos tener y nos esforzamos mucho por vivirlas.

El amor parece sobrepasar todas las emociones y proporcionar una unión y conexión especial. Aunque todos sabemos lo que queremos decir cuando hablamos del amor, siempre es un fenómeno complejo y difícil. Sobre este tema se ha cantado, escrito y hablado más que sobre cualquier otro. Dar y tomar amor proporciona una agradable sensación y da sentido a la vida. El amor tiene muchas formas: las personas se pueden amar como pareja, amigo, madre, padre, hermano o hermana pero también en nuestro trabajo podemos experimentar mucho amor.

En el acto de amor, el que da y recibe forman una unidad y no se experimenta la separación. Pero esta situación tan idealizada no sucede tan a menudo como quisiéramos. Cuando las personas no reciben o dan amor durante mucho tiempo pueden marchitarse y morir. El no poder expresar amor es quizás más difícil que no recibirlo ya que expresa una incapacidad. Se trata a menudo de un bloqueo de emociones (miedo, tristeza, rabia) por lo que el amor no puede encontrar expresión. Algunas personas han sido dañadas emocionalmente de tal manera que no pueden amar de una manera saludable. La terapia es una posibilidad de liberar emociones de tal manera que se crea nuevamente un espacio para amar.

10.5 TRATAR LA RESISTENCIA, MALA VOLUNTAD Y REINCIDENCIA

Todos los terapeutas experimentan fases en el proceso terapéutico en el que todo parece transcurrir con dificultad mientras que el cliente se esfuerza por mejorar. Se trata a veces de una mecánica de defensa del cliente. Freud, el renombrado psiquiatra, describió el fenómeno de los mecanismos de defensa: los recuerdos dolorosos se suprimen hacia el inconsciente para poder sobrevivir emocionalmente. Después de un tiempo el sentimiento de dolor vuelve a reaparecer ya sea como malestares síquicos o físicos. Puede demorarse mucho pero a largo plazo el dolor se debe hacer consciente. En efecto, es un mecanismo muy útil pero si durante mucho tiempo el sentimiento no se hace consciente, puede ser muy perjudicial para el cliente. Este es el momento en el que muchas personas piden ayuda a un terapeuta, porque ellos mismos no saben como salir de ese problema. La terapia moderna no se basa en las teorías psicoanalíticas pero el concepto de mecanismos de defensa es utilizado para poder comprender al cliente.

Aunque hay muchos más, a continuación los mecanismos de defensa más frecuentes:

- Suprimir: un fuerte deseo, necesidad o recuerdo emocional se suprime hacia el inconsciente para no sentirlo o ser consciente de el. Los deseos sexuales pueden ser completamente suprimidos porque generan miedo.
- Negación: negar los hechos para no sentir los recuerdos o la realidad. Alguien que pierde a su pareja, por ejemplo, puede negar su muerte y pretender que la persona todavía vive. Una adicción al alcohol o drogas también se puede negar.
- Racionalización: tratar un sentimiento de una manera analítica para no sentirlo. En un funeral, por ejemplo, sólo prestar atención por los detalles en lugar de sentir el dolor y expresarlo. Los hombres tienden más a este mecanismo que las mujeres.

- **Evasión:** el evitar cuidadosamente algo por miedo a que surja una emoción no deseada. Por ejemplo, ver la televisión en lugar de hablar con tu pareja de un problema que hay en la relación.
- **Proyección:** el atribuir una cualidad propia a otra persona. Por ejemplo: pensar que otras personas son agresivas hacia ti mientras que tú eres el que se comporta agresivamente.
- **Sublimación:** el canalizar un impulso inaceptable en una forma más aceptable. La agresión, por ejemplo, se puede esconder en un deporte o participación en las fuerzas armadas. Este es el mecanismo más aceptado y saludable porque utiliza la energía suprimida.
- **Identificación:** el disminuir los sentimientos de temor al adoptar el comportamiento de una persona en la que confiamos. Te puedes identificar por ejemplo con uno de tus padres.
- **Regresión:** el volver a una fase en la que te sentiste seguro y confiado. En los momentos de temor, empezar a chuparte el dedo y tomar la posición de un feto, por ejemplo.
- **Reacción:** el expresar el sentimiento opuesto al primer impulso. Comportarte muy dulcemente con alguien con el que realmente estás enfadado.

Estos mecanismos de defensa se observan en diversas medidas en los clientes y son en principio reacciones normales a sucesos intensos. Únicamente cuando las personas no pueden funcionar bien en sus vidas cotidianas, es aconsejable empezar con una terapia para trabajar la disfunción. Un terapeuta que trabaja de acuerdo al modelo terapéutico puede ayudar al cliente a hacer consciente los mecanismos de defensa que utiliza durante la fase de esclarecimiento, a profundizarlos en la fase de matización y a continuación trabajarlos directamente en la fase de trabajo. La duración de las diversas fases de la terapia depende naturalmente de la seriedad de la situación. A veces se necesita mucho tiempo para ver un problema con claridad y poder avanzar hacia la siguiente fase.

EL FEEDBACK DURANTE LA TERAPIA

Es muy normal que un cliente se desanime varias veces durante la terapia. Puede ser muy agradable para un cliente el interés que muestra el terapeuta al escuchar sus problemas pero llega un momento en la terapia en el que tendrá que hacer comprensiones y trabajar con ellas. Una terapia implica muchos altibajos; a menudo dar dos pasos hacia adelante para retroceder uno. No es agradable pero necesario para avanzar. Es muy importante que tanto el terapeuta como el cliente sean conscientes de este proceso. Si el cliente empieza a perder la motivación, el terapeuta tiene que advertirle que es normal en la terapia. Una buena manera de motivar al cliente es darle feedback haciendo referencia a los progresos que ha hecho.

Se recomienda utilizar la siguiente estructura al dar feedback:

- **Hacer cumplidos:** El terapeuta afirma positivamente al cliente. Esto puede tener un efecto sorprendente porque a menudo se desaniman y ven las cosas negativamente. Por ello no esperan recibir ningún cumplido. Es importante notar la reacción del cliente para observar si el efecto es positivo. Si el cliente asiente o sonríe acepta el cumplido. Por el contrario, a veces demuestra que el contenido no es asimilado. Es por ello importante no utilizarlo como un truco para elevar la moral del cliente.
- **Construir un puente:** Esta es la parte del feedback que une los cumplidos con la última parte, las sugerencias y tareas. Cada tarea o sugerencia debe experimentarse como apropiada al igual que los cumplidos. El puente ofrece la motivación para el trabajo.

- Dar tareas: esta parte consiste en tareas de observación y de comportamiento. Con la tarea de observar, el terapeuta sugiere observar un aspecto específico de la vida del cliente para ayudarle a encontrar el camino hacia una solución. El cliente puede observar los días o momentos en que se siente mejor o cuando el problema se agrava. Podría observar qué es diferente de lo normal. Una tarea de comportamiento requiere una acción por parte del cliente con el objeto de facilitar la manifestación de una posible solución. El cliente ha expresado que se siente bien cuando se encuentra en compañía de una persona en especial. El terapeuta le puede sugerir confiar más en esa persona, por ejemplo.

LA PETICIÓN DE UN MILAGRO

Hay situaciones en las que el cliente no encuentra salida. Los problemas se acumulan y parecen sin solución. El cliente se desanima cada vez más y el terapeuta ha hecho todo lo posible sin resultado. En esta situación la petición de un milagro puede ayudar. El terapeuta le pide al cliente que se imagine que por medio de un milagro todos sus problemas se solucionan y como sería esa situación. A menudo el cliente empieza con la imagen de una vida diferente y mejor. Esa respuesta puede ofrecer indicios del camino a seguir en la terapia. La petición de un milagro ofrece las siguientes ventajas:

- El cliente puede reflexionar sin ningún límite sobre el tipo de vida que quisiera tener, sin las restricciones normales. Esto le puede ofrecer sorprendentes comprensiones.
- La petición está dirigida hacia el futuro. Evoca una imagen de una vida satisfactoria por lo que la atención se empieza a desplazar de pensar en problemas hacia pensamientos de posibles soluciones.
- El cliente se anima generalmente al responder. Empieza a trabajar con mayor atención y más entusiasmo porque le parece una tarea agradable.

LA RECAÍDA

También después de finalizar una terapia se experimentan recaídas, a veces muchos meses después. Esto le puede suceder a cualquier cliente. Se habla de una recaída cuando se experimentan nuevamente molestias después de una terapia exitosa y un período de varios meses sin dolencias. Un cliente puede haber alcanzado muchas metas en la terapia y aún así no es conveniente descansar en los laureles. Cuando la terapia finaliza siempre existe el peligro de una recaída aunque se haya trabajado mucho. Naturalmente hay diferencias en la recaída basadas en la duración, la seriedad de las molestias, la edad y el carácter del cliente. Por eso es difícil formular un modelo de prevención de recaídas. Se ofrecen únicamente indicaciones para prevenir una recaída.

INDICACIONES PARA PREVENIR UNA RECAÍDA

- Disminuir la frecuencia de las visitas poco a poco, de una vez por semana a una vez cada tres o cuatro semanas, hasta llegar a concertar las citas según la necesidad.
- Identificar las situaciones que contienen un riesgo de recaída y aprender a manejarlas.
- Tener en mente las personas de confianza con las que se puede hablar en los momentos de necesidad como la pareja, un(a) amigo (a) o colega.
- Buscar la manera de relajarse regularmente y mantenerse activo físicamente. El tipo de relajación o deporte depende de las preferencias de la persona.

PREGUNTAS DE OPCION MÚLTIPLE - LECCIÓN 10

Escoge una de las cuatro opciones.

1. ¿Cuales son las condiciones básicas para una correcta actitud terapéutica?
 - a) Empatía.
 - b) Aceptación.
 - c) Honestidad.
 - d) Todas las opciones.
2. ¿Es apropiado llevar una administración de los clientes?
 - a) Sí, cuando la clientela va en aumento.
 - b) Sí, cuando empiezas a trabajar con clientes.
 - c) No, pero hay que tomar un seguro para la jubilación.
 - d) Sí, pero necesitas tomar un seguro para la jubilación.
3. ¿Cuáles son las fases del modelo terapéutico?
 - a) Aclarar.
 - b) Matizar.
 - c) Trabajar.
 - d) Todas las opciones.
4. ¿Qué es el “contrato”?
 - a) Los acuerdos escritos de la terapia.
 - b) Los acuerdos verbales de la remuneración.
 - c) Los acuerdos verbales de la terapia.
 - d) Los acuerdos escritos de la remuneración.
5. La más importante aptitud de un terapeuta es:
 - a) El hablar.
 - b) El ayudar.
 - c) Permitir al cliente que hable.
 - d) Escuchar con atención.
6. ¿Qué significa re-etiquetar positivamente?
 - a) Expresar un dilema.
 - b) Una manera de dirigir a los clientes hacia una comprensión positiva.
 - c) Ofrecer una solución para el dilema.
 - d) Ofrecer alternativas para el dilema.
7. ¿Cuáles son las condiciones que una sub-meta debe satisfacer?
 - a) Estar formulada de una manera específica y concreta.
 - b) Estar cercana en el tiempo.
 - c) Tener un grado de dificultad estimulante.
 - d) Todas las opciones.
8. ¿Cuál es una de las emociones más comunes durante la terapia?
 - a) Llorar.
 - b) Reír.
 - c) Miedo.
 - d) Tristeza.

9. ¿Qué son los malestares psicosomáticos?
 - a) Los malestares físicos con un origen emocional.
 - b) Un malestar emocional sin una molestia física.
 - c) Un malestar físico sin un origen emocional.
 - d) Ninguna de las opciones.
10. ¿Qué es la “petición de un milagro”?
 - a) El origen de los problemas.
 - b) Un milagro que soluciona los problemas.
 - c) El origen de la solución.
 - d) Una visualización de la solución.
11. Se dice que hay una recaída cuando hay:
 - a) Malestares después de un tratamiento exitoso.
 - b) Malestares después de un tratamiento sin éxito.
 - c) Una enfermedad.
 - d) Una adicción.
12. ¿Cuál es el significado de un mecanismo de defensa?
 - a) Un método terapéutico.
 - b) Una sub-meta de la terapia.
 - c) Los recuerdos dolorosos se suprimen hacia el inconsciente para poder sobrevivir emocionalmente.
 - d) Una manera de experimentar el dolor de una experiencia.
13. ¿Se recomienda el feed-back durante la terapia?
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Sí, hacer afirmaciones positivas.
 - d) No, sólo si el cliente las solicita.
14. La ausencia de emociones durante la terapia:
 - a) Es beneficiosa.
 - b) Oculta sentimientos o recuerdos dolorosos.
 - c) Es de vital importancia.
 - d) Dificulta la labor del terapeuta.
15. ¿Son efectivas las medidas de prevención de recaída?
 - a) Sí, siguiendo ciertas pautas.
 - b) Sí, cuando el cliente no quiere recaer.
 - c) No.
 - d) Sí, cuando el terapeuta es estricto con el cliente.